

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Matutinidad-Vespertinidad de Horne y Östberg, versión española (completa, 19 ítems) (MEQ-SA)

Eje VI • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual
— versión completa (MEQ-SA, 19 ítems), no la forma reducida rMEQ de 5 ítems

1. Identificación

Familia / sigla	MEQ-SA
Nombre completo	Cuestionario de Matutinidad-Vespertinidad de Horne y Östberg — versión española completa
Versión / edición	Traducción y adaptación al español (revisada), 19 ítems, basada en la versión automatizada del Center for Environmental Therapeutics (CET).
Idioma	Español.
Autores (original)	Horne JA, Östberg O (originales). Adaptación al automatizado: Terman M, Rifkin JB, Jacobs J, White TM. Traducción española: Rol de Lama MA, Baño Otálora B, Mondéjar Abenza MT, Sarabia Carazo JA (Universidad de Murcia).
Año (original / traducción)	1976 (original); traducción y adaptación española sin fecha exacta verificada en el documento (Copyright de la versión CET: 2008).
Tiempo estimado	10 minutos

2. Eje y pregunta clínica

Eje primario	EJE VI - SALUD FÍSICA, ESTILO DE VIDA Y MEDICINA CONDUCTUAL
Etiquetas	Cronotipo; ritmo circadiano; sueño; matutinidad-vespertinidad.
Pregunta clínica que responde	¿Qué factores corporales/médicos/conductuales inciden?

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: cronotipo individual (matutinidad-vespertinidad), es decir, la preferencia circadiana estable de una persona por horarios de actividad y sueño más tempranos (tipo matutino) o más tardíos (tipo vespertino).

Finalidad: clasificar a la persona en un tipo circadiano (matutino, intermedio o vespertino) y, en el contexto original de sus autores (CET), orientar el horario óptimo de aplicación de luminoterapia en depresión estacional; de uso más general en investigación y clínica del sueño para caracterizar el cronotipo.

Usos apropiados:

- Evaluación del cronotipo en investigación y clínica del sueño, cronobiología y medicina conductual.
- Complemento a otros instrumentos de sueño de este acervo (PSQI, ISI) para caracterizar el perfil circadiano del paciente.
- Orientación (no prescripción) sobre horarios de luminoterapia, exclusivamente bajo supervisión de un profesional especializado.

Usos NO apropiados:

- Diagnóstico de trastornos del ritmo circadiano del sueño-vigilia (requiere evaluación especializada, p. ej. actigrafía, diario de sueño, criterios CIE-11/ICSD).
- Prescripción autónoma de luminoterapia sin supervisión médica: el propio documento advierte que 'ninguna persona con depresión clínica debería someterse a luminoterapia a menos que sea de forma controlada y bajo supervisión médica'.
- Aplicación e interpretación en trabajadores a turnos, desempleados o personas con horarios de sueño atípicos sin cautela adicional (el propio instrumento advierte menor fiabilidad en estos casos).

4. Población, contexto, informante y modalidad

Población	Adultos; el propio documento advierte limitaciones en trabajadores a turnos, desempleados o con horarios de sueño inusuales.
Contexto de aplicación	Investigación y clínica del sueño, cronobiología, psiquiatría (contexto de depresión estacional en el desarrollo original).
Informante	Autoinforme.

Modalidad de administración	Papel y lápiz; individual.
------------------------------------	----------------------------

5. Estructura y administración

Número de ítems	19
Periodo temporal de referencia	últimas semanas
Formato de respuesta	Opción múltiple
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes consultadas (estimación editorial: 10-15 minutos, dada su extensión de 19 ítems).

6. Dimensiones y puntuaciones

Instrumento unidimensional: no tiene subescalas: todas las 19 preguntas contribuyen a una única puntuación total de matutinidad-vespertinidad.

7. Sistema de puntuación

Regla de puntuación	Suma de los puntos asignados a la opción marcada en cada una de las 19 preguntas (los valores están impresos junto a cada opción en el propio cuestionario).
Ítems invertidos	No aplica como tal: cada ítem tiene su propia escala de puntuación ad hoc impresa (no es una escala Likert uniforme invertible).
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible / puntos de corte	Rango total 16-86. 16-30 Vespertino extremo; 31-41 Vespertino moderado; 42-58 Intermedio; 59-69 Matutino moderado; 70-86 Matutino extremo. Fuente: texto del propio protocolo (CET, adaptación de Horne & Östberg 1976).

8. Evidencia psicométrica en español / LatAm

No se localizó en esta verificación un estudio de validación psicométrica específico en población española (más allá de la referencia a una 'Estandarización de una escala reducida de matutinidad en población española' de Adán & Almirall, que corresponde a la forma REDUCIDA rMEQ de 5 ítems, no a esta versión completa de 19) — no verificado para la versión completa aquí incluida. El instrumento original (Horne & Östberg, 1976)

cuenta con evidencia extensa de fiabilidad y validez a nivel internacional en la literatura de cronobiología.

9. Adaptación cultural y norma local

Traducción española coordinada por un equipo de la Universidad de Murcia (cronobiología), publicada por el Center for Environmental Therapeutics; no se verificó en esta sesión un estudio formal de validación psicométrica de esta traducción completa de 19 ítems en muestra española — no verificado. Sí existe, de forma distinta, una estandarización publicada para la forma reducida (rMEQ, 5 ítems) de Adán & Almirall, no incluida en este acervo (ver advertencia en Fuente_y_uso.md sobre la elección de la versión completa por razones de licencia verificable).

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

- Instrumento de autoinforme sobre preferencia circadiana; no diagnostica trastornos del ritmo circadiano ni sustituye actigrafía o polisomnografía.
- El propio documento advierte fiabilidad reducida en trabajadores a turnos, personas sin empleo regular, o con enfermedad/medicación que afecte el horario de sueño.
- Las recomendaciones de horario de luminoterapia incluidas en el documento original exceden el alcance de una evaluación psicológica multieje y requieren supervisión médica especializada; no deben aplicarse de forma autónoma.
- No se verificó adaptación psicométrica específica de esta versión completa (19 ítems) en población española o latinoamericana en esta sesión.
- No emplear como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El documento fuente declara explícitamente: 'Está permitida la reproducción con fines no comerciales.' © 2008, Center for Environmental Therapeutics (CET), Nueva York. El Protocolo.pdf de este acervo es una reconstrucción textual verificada (no el binario original del titular, que el entorno de red de este proceso no pudo descargar) — ver Fuente_y_uso.md para el detalle de la verificación.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Horne JA, Östberg O (1976). A self-assessment questionnaire to determine morningness-eveningness in human circadian rhythms. *International Journal of Chronobiology*, 4, 97-100.

Terman M, Terman JS (2005). Light therapy for seasonal and nonseasonal depression: efficacy, protocol, safety, and side effects. *CNS Spectrums*, 10, 647-663.

Center for Environmental Therapeutics (2008). Versión castellana del Cuestionario de Matutinidad-Vespertinidad de Horne y Östberg (revisado). <https://cet.org/wp-content/uploads/2018/01/MEQ-SA-ESP.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

13. Activos disponibles, hash y estado QA

Activos disponibles	Protocolo.pdf (reconstrucción textual verificada con reportlab, 19 ítems completos + escala de puntuación + advertencias del titular). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto (generado por proceso externo posterior a esta entrega).
Estado QA	Protocolo reconstruido abre correctamente y contiene el texto íntegro verificado (comprobado con pypdf). Requiere revisión humana antes de uso clínico formal; se recomienda cotejar contra el PDF original del titular cuando la red lo permita.

14. Control de versión

Fecha	2026-08-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0